



المفهوم العام للإصابات :

تشق كلمة الإصابة من الأصل اللاتيني 'nury وهي تعني تلف أو إعاقة فالإصابة هي أي تلف سواء كان هذا التلف مصاحبا أو غير مصاحبا بتهتك في الأنسجة نتيجة لأي تأثير خارجي ثواء كان هذا التأثير ميكانيكيا ♦ عضويا ♦ كيميائيا

تعريف الإصابة الرياضية :

يتفق بعض العلماء علي ان الإصابة الرياضية هي تغير ضار يحدث نتيجة حدث غير متوقع تم أثناء ممارسة النشاط الرياضي ينتج عنه أضرار فسيولوجية تشريحية للمارس كما يؤدي الي آلام مصاحبة لممارس النشاط الرياضي

تصنيف الإصابات وفقا لشدة ودرجة الإصابة :

إصابات بسيطة (درجة أولي) : 1 grade

هي الإصابات التي لاتعوق اللاعب عن الأداء في الملعب مثال (الكدمات البسيطة ♦ الرضوض البسيطة ♦ التقلص العضلي) وتحدث هذه الإصابات بنسبة 88 : 90 %

إصابات متوسطة (درجة ثانية) : 2 grade

هي الإصابات التي تعوق اللاعب عن الأداء في الملعب أو تمنعه عن تكملة المباراة مثال (الشد العضلي بدرجاته ♦ التمزق العضلي بدرجاته ♦ تمزق الأربطة بدرجاته وهذه الإصابات تعوق اللاعب عن الأداء لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلي أربع أسابيع

إصابات شديدة (درجة ثالثة) : 3 grade

هي الإصابات شديدة الخطورة والتي تعيق اللاعب تماما عن الإستمرار في الأداء مثال (الكسور- الخلع ♦ تمزق الأربطة الصليبية والجانبية للركبة) وهذه الإصابات تتراوح مدتها ما بين شهر وسنة وقد تجبر اللاعب علي الإعتزال مبكرا

الأسباب العامة لحدوث الإصابات الرياضية :

أولا العوامل الخارجية

- 1- عدم تقنين الحمل التدريبي مع عدم الإنتظام في التدريب والمنافسة
- 2- عدم التكامل في تدريب عناصر اللياقة البدنية وعدم الإهتمام بالنواحي الفنية والمهارية والخططيه
- 3- عدم كفاية الإعداد البدني للاعب وخاصة بالنسبة للقوة العضلية
- 4- عدم الإهتمام بالإحماء المناسب لنوع النشاط
- 5- سوء الأحوال المناخية التي تمثل من 2 : 6 % من حالات الإصابة
- 6- عدم ملائمة الملابس لنوع الرياضة وعدم ملائمتها للظروف المناخية
- 7- السلوك الغير السليم وفقد الروح الرياضية والخشونة المتعمده بين اللاعبين
- 8- إنخفاض مستوي الحكام وتساهلهم في بعض الأحيان
- 9- عدم مراعاة عامل السن ومرحلة النضج

ثانيا العوامل الداخلية :

- 1- الإنقطاع عن التدريب لفترات طويلة
- 2- حالات الإرهاق والإعياء الشديد (التعب)
- 3- عدم مراعاة عامل الجنس بين الذكور والإناث
- 4- عدم كفاية الدورة الدموية لتعطيه إحتياجات العضلات من الدم
- 5- زيادة الوزن حيث يسبب ضغط قوي علي المفاصل
- 6- العوامل النفسية للرياضي وحالته أثناء أداء التمرين
- 7- المشكلات وضغوط الحياه اليوميه
- 8- تعاطي الرياضي للمنشطات
- 9- عدم تمتع اللاعب بقدر كافي من المرونه

الأسس الوقائية لتجنب حدوث الإصابات

- 1- الكشف والسجل الطبي
- 2- الإحماء

3- أدوات الوقاية مثال (الشنكار في كرة القدم ♦ حامي الرأس في السلاح)

4- الإهتمام بالتوافق العضلي

5- إختيار الأجهزة والأدوات

6- أرضيات الملاعب

7- الغذاء المناسب

8- العادات الصحية السليمة

9- النواحي النفسية

الإسعافات الأولية للإصابات الرياضية : a'd frst

تعريف الإسعافات الأولية :

العناية الفورية والطريقة التي يتلقاها ضحايا الحوادث والأمراض الفجائية واللاعبين في المنافسات الرياضية والتي تحافظ علي حياتهم أو تمنع حدوث مضاعفات .

أهداف الإسعافات الأولية

1- المحافظه علي حياة المصاب

2- منع مضاعفات الإصابة

3- العمل علي رفع معنويات المصاب

4- الحرص اثناء نقل المصاب وخاصة إصابات العمود الفقري والرقبة

واجبات المسعف :

1- أن يكون هادئا وبيث الطمأنينه للمصاب

2- أن يحترث من أن يصدم من هول الإصابة

3- التصرف بسرعة وهدوء

4- القيام بسرعة أداء التنفس الصناعي إذا لزم الأمر

5- منع تراحم الناس حول المصاب

6- إيقاف النزيف

7- وضع المصاب في الوضع الصحيح

8- عدم إعطاء المصاب أي شئ عن طريق الفم إذا كان فاقد للوعي

9- طلب المساعدة من الآخرين

10- عدم الإسراف في محاولة إجراء الإسعافات الأولية

الإسعافات الأولية للإصابات الرياضية :

نتيجة للتقدم العلمي الذي نشهده في السنوات الأخيرة ظهر أسلوب الإسعافات الأولية يعتمد علي أسس علمية ويساهم للحد من آثار الإصابة ويقلل من ظهور أعراض الإصابة ويتحكم في التليفات التي يحتاجها الجسم ويمثل هذا الأسلوب في

قاعدة PRICE

الإنعاش القلبي الرئوي

C P R

هي عملية مزدوجة يقوم المسعف فيها بإنعاش القلب والرئه .

تعتبر عملية الإنعاش القلبي الرئوي هامة جدا حيث أنها تكسب الوقت بحيث يتم تزويد الرئه بالأكسجين والقلب بالدم إلي حين وصول سيارة الإسعاف .

الأسباب المؤدية لتوقف التنفس :

الغرق ♦ الإختناق ♦ الصدمة الكهربائية ♦ الإفراط في تناول بعض الأدوية وخصوصا المهدئات والمخدرات ♦ النوبة القلبية ♦ إصابة الرأس والصدر .

كيفية تنفيذ خطوات الإنعاش القلبي R P C g've to How ?? ؟؟

1- فحص واستجابة الشخص : محاولة الحصول علي إجابة بطرح أسئلة وهز كتف المصاب بلطف إذ لم يكن هناك إستجابته

2- فتح مجري التنفس : ثني الرأس للخلف ورفع الذقن لتفتح مجري التنفس وإزالة أي إنسداد واضح

خطوات فتح مجري التنفس والحفاظ عليه مفتوحا

1- إجلس علي ركبتك جانبا إلي جانب المصاب

2- إستعمال السبابه والوسطي لرفع ذقن المصاب بإحدى يديك

3- ضع راحة يدك الأخرى علي جبين المصاب ثم اضغط لأسفل

4- انظر داخل فم المصاب للتأكد من خلو أي جسم خارجي

(ملحوظة) إذا صاحب تنفس المصاب صوت فإن ذلك يدل علي وجود إنسداد في مجري التنفس فتقوم بتسليك مجري التنفس لإخراج ماتراه من جسم غريب

- 3- فحص التنفس : إفحص إذا كان هناك تنفس (أنظر ، إسمع ، حس) (feel, listen, look) لمدة 5 ثوان وذلك للتحقق فيما إذا كان المصاب يتنفس أم لا
- 4- التنفس الصناعي : إعط نفسين إنقاذيين فعليين للمصاب مدة كل نفس 2 ثانيه مع مراقبة إرتفاع الصدر ثم توقف لمدة ثانية بينهما لتسمح بخروج الهواء .

طريقة التنفس الصناعي :

بعد التأكد من تمرير مجري الهواء كما ذكرنا إقفل أنف المصاب ثم إطبق بضمك علي فم المصاب بإحكام ثم انفخ فيه بعمق حتي تلاحظ علو الصدر أثناء ذلك كرر العملية أكثر من مره كل مرتين راقب تنفس المصاب .

(ملحوظه) في حالة عدم وجود علو في صدر المصاب أثناء النفخ هذا يعني ان هناك إنسداد في مجري الهواء أدخل إصبعك في فم المصاب لإستخراج ما قد يكون سبب لذلك

- 5- فحص الدورة الدمويه : إفحص علامات دوران الدم ليس أكثر 15 ثانية

هل هناك أي علامات دوران مثل جس النبض الثباتي .

التنفس ، السعال ، الحركه في أحد الأطراف

إذا لم توجد علامات الدوران إبدأ بالإنعاش القلبي الرئوي

الإنعاش القلبي الرئوي :

قم بالتناوب بعمل 15 ضغطه علي الصدر ونفسين

بعد أربع دورات من (15 ضغطه + نفسين) أو 1 دقيقه أعد فحص النبض إذا كان هناك نبض ، إفحص التنفس إذا لم يكن هناك تنفس كل 5 ثوان مع مراقبة النبض كل 90 ثانية .

❖ إذا لم يوجد نبض إستمر بالإنعاش القلبي الرئوي

متي تتوقف عن إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ؟؟

1- عودة النبض والتنفس للمريض

2- وصول الفرقة الإسعافية

3- الشعور بالتعب والاجهاد الشديدين

❖ إذا بدأ المصاب يتنفس ولكنه ظل فاقد الوعي ضعه في وضع الإنفاة

وسائل العلاج الطبيعى المستخدمه في إسعاف وتأهيل الإصابات الرياضية :

1- العلاج بالتبريد : وهي طريقة علاج قديمه جدا وشيقة الإستخدام وتؤدي إلي خفض درجة حرارة الجلد أثناء المعالجة وتنقسم إلي :-

1- وسائل وأنية الثلج 2- التغطيس والغمر 3- كمادات الثلج

4- التدليك بالثلج 5- كأس الهواء بالثلج المجروش

2- الكمادات الساخنة : وهي أحد الوسائل في علاج وتأهيل الإصابات الرياضية لما لها من تأثير حراري علي الأنسجه المصابة والتي تعمل علي تحسين الدورة الدمويه في المنطقه المصابة .

3- الحمامات التصادمية : تضمن تلك المعالجة المزج بين الحمامات الباردة والساخنة عن طريق التغطيس المتعاقب ويكون خلالها درجة حرارة الماء الساخن 45 : 50 م ودرجة حرارة الماء البارد من 10 : 15 م .

4- شمع البرافين : يستخدم في العلاج الطبيعى ويكون مداه الحراري ما بين 50 : 55 م وتفيد الحرارة التي نحصل عليها من الشمع الساخن في تخفيف الألم وتثبيت المفاصل .

5- الموجات القصيرة wave short : هي أحد اشكال الحرارة التي تنتج بواسطه تيار كهربائي ذو تردد عالي وتعمل علي تسخين الأنسجه العميقه دون أن تعرضها للحرق .

❖ التمرينات التأهيلية [التأهيل البدني] Rehab'itaton

تعريف التأهيل البدني :

هو عودة العضو المصاب مره اخري إلي طبيعته [ما كان عليه قبل الإصابة] أو أقرب ما يكون إليه في العمل الوظيفي قبل الإصابة

أهداف التأهيل البدني الرياضي

❖ أهداف أساسية قصيرة المدى :-

1- تخفيف الألم 2- إعادة المدي الحركي للمفصل 3- تحسين القوه العضلية

أهداف بعيدة المدى :-

1- إستعادة المستوي الوظيفي للمصاب

2- المحافظه علي درجة اللياقة البدنية

3- الوقاية من تكرار حدوث الإصابة في نفس المنطقة

4- مساعدة اللاعب للوصول إلي أقصى ميكانيكية

5- تنمية المهارات البدنية الخاصة بالرياضة التي يمارسها الرياضي

التقلص العضلي

Spasm

تعريف التقلص العضلي :

هو حدوث تشنج عضلي زائد دون إنزار سابق في عضلة أو مجموعة من العضلات بحيث لا يستطيع اللاعب التخلص من هذا التقلص الشديد المؤلم بمفرده وربما يستمر هذا التشنج لعدة ثوان أو بضع دقائق ، وأكثر عضلات الجسم تعرضا لهذه الإصابة هي (عضلة سمانة الساق * باطن القدم * العضلات الخلفية وال أمامية للفخذ)

الأسباب العامة للتقلص العضلي :

- 1- الإستمرار في العمل العضلي لفترات طويلة دون الحصول علي فترات الراحة البينية او نقص في بعض عناصر اللياقة البدنية
- 2- النقص الشديد في كمية الأوكسجين أو الهليكو*ين أو الأملاح في الجسم
- 3- عدم العناية بوسائل الإحماء المناسب (التسخين)
- 4- عدم الحصول علي الغذاء المتنوع ووجود نقص في بعض الفيتامينات والأملاح
- 5- عدم إنتظام الدوره الدمويه بالعضلة أثناء المجهودات المستمره

أعراض التقلص العضلي :

- 1- إنقباضات لا إرادية مؤلمه بالعضلات غالبا في الساق
- 2- الإحساس بالألم الشديد مكان العضله المتقلصه وربما الطرف كله
- 3- عدم القدره علي تحريك العضله المصابه أو العضلات المصابه المحيطه بها
- 4- عند فحص العضله المتشنجه نجدها متصلبه لا يستطيع اللاعب تحمل ملاسمة أصابعنا لها نظرا لشدة حساسيتها

الإسعافات الأولية للتقلص العضلي :

- 1- سرعة إتخاذ اللاعب لأفضل أو ضاع الراحة علي أرض الملعب ثم تشجيعه علي مد المفصل التي تعمل عليه العضله المتقلصه بحيث تكون الحركه في عكس الإتجاه الطبيعي الذي تعمل عليه العضلات
- 2- بعد التأكد من حصول العضله علي الإسترخاء وإزالة حالة التوتر يمكن إستعمال حركات التدليك المسحي السطحي بواسطة بعض الدهانات المدفئه والمزليه للألم تدريجيا
- 3- عدم محاولة إستخدام حركات التدليك العميق أو العنيف السريع أثناء الإصابة
- 4- عمل كمادات ساخنه للمنطقه المصابه
- 5- تطبيق نظام كؤوس الهواء علي منطقة حدوث التقلص العضلي

التمزق العضلي

Stra'n

تعريف التمزق العضلي :

هو عبارة عن تمزق الكيس المغلف للعضلات أو الألياف العضليه أو الأوتار نتيجة مجهود عضلي شديد عنيف ومفاجئ بدرجة أكبر من قدرة العضلة علي تحمل هذا المجهود

أنواع التمزق العضلي :-

- 1- الشد الزائد : ويحدث فيه شد أكثر من اللازم لبعض الألياف العضليه قد يؤدي إلي تمزق الكيس المغلف للعضلة
- 2- التمزق الجزئي (الغير كامل) : هو تمزق لبعض الألياف والأنسجة العضلية في أي مكان بالعضلة وخاصة في باطن العضلة أو مكان إندغامها وهذه الإصابة أشد من السابقة
- 3- التمزق الكلي (التمزق الكامل) : ويعتبر هذا النوع أعنف وأصعب أنواع التمزق حيث تنفصل فيه العضلة سواء مكان المنشأ أو الإندغام وتكون الإصابة واضحة وملموسة

أسباب التمزق العضلي :

- 1- الإنقباض للعضلات وهي غير مهيأه للإنقباض
- 2- المجهود العضلي الزائد بدرجة أكبر من قدرة العضلات علي تحمله
- 3- إهمال الإحماء وعدم الإهتمام بتهيئة الجهاز العضلي للقيام بالمجهود
- 4- قصر العضلات تشريحيا وعدم مطايطتها بالدرجة التي تتطلبها طبيعة الحركات والمهارة التي يؤديها اللاعب
- 5- تخطي الحدود الفسيولوجية لمطاطية العضلة
- 6- عدم تناسق الإتران بين القوي العضلية العاملة والعضلات المضادة أو المثبته للعضلات الأساسية
- 7- إشتراك اللاعب في المباريات قبل تمام شفائه من التمزق أو الشد السابق
- 8- إشتراك اللاعب وهو مريض أو مصاب ولو إصابة مبدئية أو بسيطه مثل الإلتهاب العضلي
- 9- ضغط أو ضربة مفاجئة من الخصم

أعراض التمزق العضلي :

- 1- ألم مكان الإصابة مثل لسعة الكرباج أو ضربة آلة حاده أو قطع بالسكين

- 2- سماع صوت (فرقعة في العضلة المصابة)
- 3- تورم وتجمع دموي وذلك نتيجة حدوث النزيف الداخلي
- 4- عدم قدرة العضلة المصابة علي أداء وظيفتها وشدة الحساسية
- 5- يكون التجمع الدموي واضحا حول مكان الإصابة بعد 48 ساعة من الإصابة
- 6- في الحالات الشديدة يستمر الورم 72 ساعة علي الإصابة
- 7- إرتفاع درجة حرارة الجزء المصاب
- 8- تغير لون الجلد من الإحمرار الطبيعي إلي الأزرق إلي الأصفر
- 9- ملاحظة وجود فجوة في العضلة المتمزقة ونلاحظه أكثر عند إنقباض العضلة

الإسعافات الأولية للتمزق العضلي :

- 1- منع اللاعب من الإستمرار في اللعب مع إتخاذ العضو المصاب أفضل أوضاع الراحة
- 2- الراحة الكاملة للاعب بدنيا ونفسيا لتجنب حدوث صدمة للاعب ، مع عدم تحريك الجزء المصاب
- 3- تستمر عمل كمادات التبريد خلال 48 : 72 ساعة بمعدل 4 : 5 مرات في اليوم
- 4- عمل رباط ضاغط مناسب حول مكان الإصابة
- 5- يجب السيطرة الكاملة علي النزيف والإنسكاب الداخلي وذلك بضرورة عدم إستعمال العضلة والراحة التامة
- 6- وضع العضلة أو العضلات المصابة في وضع الإرتخاء الكامل لتقليل التوتر أو التقلص الحادث
- 7- راحة سلبية للعضو المصاب حسب شدة ودرجة الإصابة
- 8- رفع المنطقة المصابة فوق مستوي القلب لتدفق الدم علي المنطقة المصابة
- 9- الابتعاد عن إستخدام جميع أنواع الحرارة أو التدليك طوال الفترة الحادة للإصابة منعا لزيادة النزيف

طرق الوقاية من التمزق العضلي :

- 1- تجنب المجهود العنيف أو التدريب علي مهارات جديدة واللاعب في حالة إجهاد أو مرض
- 2- الإهتمام بزيادة مطاطية العضلة والحصول علي مدي مرونة كاملة لحركة المفاصل بصورة تتفق مع المجهود العضلي
- 3- الإهتمام بتمرينات التقوية بالمقاومة والأثقال للعضلات وخاصة العاملة في النشاط الممارس

العضلات الأكثر عرضة للإصابة بالتمزق :

- 1- عضلات الفخذ الأمامية والخلفية للاعب كرة القدم ولاعبي الجري والحواجز والوثب الطويل والثلاثي والعالي
- 2- عضلة السمانة (بطن الساق muscle Calf) وتحدث الإصابة فيها لدي لاعبي العدو
- 3- مجموعة (عضلات الظهر muscle Back) ويحدث التمزق في رياضات الجمباز وكرة القدم
- 4- مجموعة عضلات الكتف وخاصة (العضلات الدالية muscle Deltoid) وتكثر إصاباتهما بالنسبة للاعبين رمي الرمح ودفع الجلة ولاعبي الكره الطائره
- 5- العضلات (المنحرفه المربعة muscle Trapezes) وخاصة للاعبين الجمباز والمصارعة

الالتواء

Sprain

تعريف الالتواء :

هو عبارة عن زحزحة مؤقتة للعظام المتصلة للمفصل ينتج عنها شد لأربطة المفصل أو تمزق جزئي أو تمزق كلي لرباط أو أكثر من أربطة المفصل

أعراض الالتواء :

- 1- ألم حاد بالمفصل نتيجة تمزق الأنسجة أو الأربطة حول المفصل
- 2- إلتهاب الغشاء الزلالي
- 3- ألم مبرح عند عمل حركة في المفصل تحدث شد في الرباط المتمزق
- 4- ورم نتيجة إنسكاب السائل الزلالي في المفصل
- 5- ألم عند الضغط علي الرباط المصاب

درجات الإصابة بالالتواء :

♦ إصابة الدرجة الأولى [خفيفة]

يحدث إلتواء خفيف للمفصل ينتج عنه شد في أحد أربطة المفصل وقد يستمر اللاعب في الأداء أو يخرج من الملعب لمدة من 1 يوم إلي 3 أيام

♦ إصابة من الدرجة الثانية [متوسطة]

يحدث إلتواء للمفصل ينتج عنه تمزق رباط أو أحد أربطة المفصل وبذلك لا يستطيع اللاعب تكملة المباراة

♦ إصابة من الدرجة الثالثة [شديدة]

يحدث إلتواء للمفصل ينتج عنه تمزق شديد في رباط أو أحد أربطة المفصل وبذلك لا يستطيع اللاعب تكملة المباراة

الإسعافات الأولية للإلتواء :

- 1- الراحة التامة للمصاب

2- عمل كمادات باردة علي العضو المصاب

3- رفع الطرف المصاب لأعلي

4- عمل رباط ضاغط للمفصل

تطبيق قاعدةPRICE في الالتواء ولكن عند تطبيق هذه القاعدة في الالتواء يجب مراعاة النسب المختلفة لتطبيق القاعدة

الكدمات

تعريف الكدمات :

هي عبارة عن هرس (تحطيم * تهتك) في الأنسجة وأعضاء الجسم المختلفة عن طريق قوة خارجية عنيفة مباشرة أو الاصطدام بجسم صلب دون حدوث أي انفصال في طبقة الجلد .

أنواع الكدمات

(كدم عضلي * كدم عصبي * كدم مفصلي * كدم عظمي)

1) كدم عضلي : يعتبر من الإصابات شديدة الشوع وخاصة في الرياضات المتضمنة للإحتكاك (كرة السلة * كرة القدم * الهوكي * اليد)

حيث يتبعه تمزق جزئي سطحي في النسيج العضلي نتيجة تعرض الجسم لضربة قوية ناتجة من عامل خارجي يؤدي إلي التهاب حاد ونزيف وورم في المنطقة المصابة .

وأكثر عضلات الجسم لهذه الإصابة (عضلات الفخذ * سمانة الساق * الكتف * اليد * مفصل الركبة)

2) كدم الأعصاب : هي عبارة عن كدم يحدث في بعض الأعصاب المكشوفة نسبيا من العضلات والأنسجة السميكة وتعتبر أكثر الإصابات المباشرة لكدمات الأعصاب وخاصة أثناء الضربات الشديدة المباشرة علي أحد مناطق سير العصب

أكثر الأعصاب التي تتعرض لهذه الكدمات (العصب الكعبري الذي يغذي العضلة ذات الثلاث رؤوس العضدية * العضلات الباسطة لمفصل المعصم وأصابع اليد * العصب الذنودي بالزراع * أو العصب الموجود بجوار رأس عظم الشظية بالساق)

3) كدم المفصل : يحدث نتيجة ضربة مباشرة علي المفصل أو السكوت المفاجئ مؤثرة بذلك علي قدرة اللاعب الأدائية

من أكثر المفاصل تعرضا لهذه الإصابة (مفصل المرفق * الركبة * القدم * الكتف) وقد يحدث نزيف داخل المحفظة مع تراكم الإنسكابات الدموية داخل المفصل وربما يحدث ورم مفصلي يظهر عقب الإصابة بعدة دقائق أو ساعات حسب شدة الإصابة

4) كدم العظام : من الممكن أن يصاب الجهاز العظمي بالكدم نتيجة التأثير بإصطدام أو الضرب العنيف والذي يؤدي إلي نزيف دموي يحدث تحت السحاق الخارجي للعظم تحت الجلد

أكثر المناطق تعرضا لهذه الإصابة هي أماكن تواجد العظام تحت الجلد مباشرة مثل (المناطق المكشوفة من عظام الوجه * عظام الساق * عظام اليد) وغالبا ما تكون الغضابة بكدمة العظام نتيجة الإصطدام بأجسام صلبة غير حادة بطريقة مباشرة أو ضربات عنيفة ويحدث الكدم غالبا بسبب السقوط والإصابات الرياضية وحوادث السيارات وفي كدمات العظام تكون معانات الألم كبيرة وينتهي الكدم خلال أيام إلي شهور

الخلع

تعريف الخلع

هو خروج أو انتقال إحدي العظام المكونة للمفصل بعيدا عن وضعها الطبيعي نتيجة عنف مباشر أو غير مباشر ويعمل علي حركة غير طبيعية في إتجاه مخالف لحركة المفصل الطبيعية

أنواع الخلع :

1) الخلع المرتد تلقائيا : تتباعد فيه الأسطح المفصلية وترجع ثانية إلي مكانها الطبيعي من تلقاء نفسها بدون تدخل وهي أسهل أنواع الخلع

2) الخلع الغير كامل أو الجزئي : وفيه تتباعد الأسطح المفصلية عن بعضها دون خروج العظام نهائيا عن أماكنها الطبيعية

3) الخلع الكامل : فيه تتباعد الأسطح المفصلية عن بعضها وخروج كل أو بعض أجزائها بالكامل عن أماكنها الطبيعية

4) الخلع المتكرر : هو تكرار حدوث الخلع لنفس المفصل أكثر من مره وربما يحتاج علاجه إلي عملية جراحية لإعادة شكل المفصل إلي وضعه الطبيعي

5) الخلع المصحوب بكسر : يعتبر من أصعب الأنواع ويحتاج إلي عملية جراحية لتثبيت الكسر وإعادة الخلع ويحدث نتيجة إصابة مباشرة لعظام المفصل

أعراض الخلع :

1) ألم مبرح عند لمس أو تحثث المفصل

2) تشوه في شكل العضو نتيجة خروج العظام عن مكانها الطبيعي

3) ظهور ورم في المنطقة المصابة

4) فقد المفصل لوظيفة الحركة فورا

5) إحمرار في مكان العضو المخلوع

العلاج :

1) وضع المفصل المخلوع في وضع مريح وعدم تحريكه لمنع أي تمزقات بالأربطة أو الأوعية الدموية .

2) إستخدام الكمادات الباردة لإيقاف النزيف وإزالة الإلتهاب وتقليل الألم .

3) إستدعاء أقرب طبيب متخصص لرد المفصل المخلوع .

4) راحة الجزء المخلوع لفترة كافية مع التثبيت لضمان عدم التكرار للخلع مما ينتج عنه مشكلة قد يصعب علاجها

5) العلاج الطبيعي لإستعادة وظيفة المفصل المخلوع وإعادة مكوناته إلي حالته الطبيعية

6) برامج التأهيل الطبي الرياضي لإعادة اللاعب المصاب إلي الملاعب

ملحوظة : يجب مراعاة عدم إستعمال أي نوع من أنواع التدليك لمنع حدوث مضاعفات غير متوقعة

الكسور

تعريف الكسور

الكسر هو انفصال العظام عن بعضها إلى جزء أو أكثر نتيجة لقوة خارجية شديدة (عنف خارجي) أو الاصطدام بجسم صلب مثل (الضرب بعصا غليظة بقوة علي الساعد ♦ اصطدام القصبية بقدم لاعب آخر بقوة)

أنواع الكسور حيث تنقسم الكسور إلى نوعين وهما :-

أ- من حيث السبب

ب- من حيث شكل الإصابة

أولا أنواع الكسور من حيث السبب :

- 1) الكسر الإصابي Traumatic : نتيجة لضربة مباشرة أو غير مباشرة
- 2) الكسر المرضي Pathological : نتيجة لإصابة العظام ببعض الأمراض
- 3) الكسر بالإجهاد Stress : نتيجة بذل مجهود زائد متكرر

ثانيا أنواع الكسور من حيث شكل الإصابة :

- أ- الكسر البسيط fractures Simple : وهو الذي يتم فيه كسر العظام دون خروجها خارج الجلد
- ب- الكسر المركب fractures Compound : وهو الذي يكون مصحوب بخروج العظم خارج الجلد مسببا جرحا نافذا في الجلد
- ج- الكسر المفتت : ويتم فيه تكسير العظام إلى قطع صغيرة
- د- كسر الغصن الأخضر : يحدث في الرياضيين الناشئين صغار السن نظرا لليونة عظمتهم

الأسباب العامة للكسور:

- 1) قوة خارجية تؤدي إلى صدمة شديدة تصيب العظم مسببة الكسر
- 2) سقوط الجسم وإصابته إصابة مباشرة فيحدث الكسر مكان الإصابة أو إصابة غير مباشرة مثل سقوط اللاعب وإسناده علي يده فيحدث الكسر في الترقوة مثلا
- 3) نتيجة أمراض وراثية خلقية في الطفل عند الولادة ترجع إلى نقص في سلامة ونضوج الخلايا
- 4) كسر مرضي نتيجة وجود مرض في العظام

الأعراض العامة للكسور

- 1) الصدمة العصبية قد تصاحب الكسور البسيطة وتلازم الكسور الشديدة وعلامات هذه الصدمة عبارة عن :
 - 1- انخفاض ضغط الدم 2- سرعة النبض و سطحيته 3- بطئ في التنفس وعمقه
 - 4- زرقة تحت الأظافر 5- برودة الأطراف 6- حدوث تشنجات وفقدان للوعي

أعراض الكسر:

- 1) وجود ألم بالمنطقة المصابة
- 2) ظهور ورم بعض دقائق من حدوث الإصابة وتغير لون الجلد المحيط
- 3) إعوجاج في الطرف المصاب في بعض الأحيان نتيجة إعوجاج العظمة المكسورة
- 4) عدم قدرة المصاب علي تحريك العضو المصاب وعدم تمكنه من القيام بوظائفه
- 5) يمكن رؤية طرف العظمة المكسورة خارج من الجروح في حالات الكسور المضاعفة
- 6) في حالات الكسور المعقدة قد تكون الدورة الدموية أو الإحساس أو الحركة غير طبيعية في الجزء السفلي من العضو المصاب مثل أصابع اليد والقدم
- 7) سماع صوت شخشة يسمى بشخشة العظام أو تكتمة في منطقة الكسر ناتج من احتكاك العظام المكسورة ببعضها البعض

مضاعفات الكسور

مضاعفات الكسور الموضوعية :

- 1) سوء الالتئام 2) تأخر الالتئام 3) عدم الالتئام
- 4) ضمور العضلات 5) تيبس المفاصل 6) تهتك الأنسجة
- 7) تشوه مكان الكسر

مضاعفات الكسور العامة :

- 1) الصدمة العصبية 2) الجلطة الدموية 3) التهاب الكلي
- 4) الجلطة الدهنية وهي التي تحدث في الكسور المضاعفة

الإسعافات الأولية للكسور

- 1) الإمتناع عن تحريك العضو المصاب
 - 2) إيقاف النزيف ومحاولة السيطرة عليه بالتلج
 - 3) وقاية العضو المصاب بجبيرة مؤقتة بسند الكسر علي حسب مكانه
 - 4) أن يوضع المصاب في الوضع المريح
 - 5) ان يحافظ علي تغطية المريض بالبساطين الكافية حتي لا يحدث له صدمة
 - 6) أن يراعي خلع الملابس عن العضو المصاب وإذا صعب وجب تمزيقها
 - 7) ينتقل المريض إلي اقرب مستشفى بسرعة مع تقليل الحركة للعض المصاب
- تحذير هام: لا تحرك المصاب حتى تدعم وتثبت الجزء المصاب لأن تحريكه قد يؤدي إلي مضاعفات مثل إصابة الأوعية الدموية أو الأعصاب أو الأنسجة لنهايتي العظمة العظم المكسور إلا إذا كان المصاب معرض للخطر لا تسمح للمصاب بالشرب أو الأكل أو التدخين لأنه قد يحتاج إلي تخدير تام عند علاجه

العمود الفقري

العمود الفقري

يتكون العمود الفقري في الإنسان من مجموعة فقرات عظمية يفصل بينها أقراص غضروفية لينه تعطي العمود الفقري المرونة في الحركة فيتمكن الشخص من عمل حركاته بسهولة

العمود الفقري

هو عمود متحرك يقع في المحور الرأسي الخلفي للجسم ويصل الطرف العلوي بالطرف السفلي فتتصل به الجمجمة من أعلي والقفص الصدري في المنطقة الصدرية والحوض في المنطقة العجزية عن طريق مفاصل زلالية وليفية .

التركيب التشريحي للعمود الفقري :

يتكون العمود الفقري في الإنسان من سلسلة من الفقرات ممتدة من أسفل الجمجمة بطول الظهر بها قناة عظمية تسمى القناة الشوكية يمر بداخلها لحبل الشوكي ويبلغ عدد هذه الفقرات 33 فقرة

1- المنطقة العنقية 7 فقرات عنقية

2- المنطقة الصدرية 12 فقرة صدرية

3- المنطقة القطنية 5 فقرات قطنية

4- المنطقة العجزية 5 فقرات عجزية ، ويكونوا ملتحمين

5- المنطقة العصعصية 4 فقرات عصعصية

أكثر المناطق عرضة للإصابة :

من أكثر المناطق عرضة للإصابة هي الـ 5 فقرات القطنية ويصابوا بالإنزلاق الغضروفي Disk وقد تصاب العنقية الأولى والثانية تصاب يخشونه

ويمر النخاع الشوكي عن طريق العمود الفقري

القرص الغضروفي :

هو عبارة عن جهاز هيدروليكي ماص للصدمات ويتكون من الصفيحة الفقرية والحلقة الليفية والنواه اللبية ، ويتكون القرص من مواد مركبة من الكولاجين وماء

النخاع الشوكي :

هو جزء من الجهاز العصبي المركزي طويل اسطواناني الشكل يشغل الثلثين العلويين للقناة الفقرية وهو إمتداد للنخاع المستطيل ويتصل عند الثقب المؤخر الأ عظم لعظم الجمجمة عند الحرف العلوي للفقرة الثانية ويمتد بعدها الخيط رفيعا طويلا غير عصبي يسمى الخيط الإلتهابي الذي بدوره ينتهي بإندغام في الفقرة الأولى العصعصية من الخلف

التكوين العام للفقرات :

يختلف حجم الفقرات في العمود الفقري من منطقة لأخرى وذلك يكفيا مع الوظيفة المطلوبة وهناك زيادة تدريجية في حجم الفقرات من أعلي لأسفل في الفقرات العنقية ذات حجم صغير نسبيا تثبيت منطقة القفص الصدري والضلع أما الفقرات القطنية أكبر وأقوي لتحمل ثقل الحجم نسبيا والفقرات العجزية بها إنحناء يساعد علي إعطاء الحوض شكله الطبيعي

الفقرات العظمية القطنية verloebræ Lumber تتكون من :

(1) النتؤ الشوكي (2) الصفيحة اليمني (3) السطح المفصلي العلوي

(4) قوس الفقرات (5) النتؤ المستعرض (6) ثقب النتؤ المستعرض

(7) جسم الفقرة

وتمتاز بأن جسم الفقرة كبير كروي الشكل والقناة الشوكية صغيرة مثلثة الشكل والشوكة الخلفية كبيرة وقوية وعريضة والنتؤ المستعرض قصير عرض ولا يوجد سطوح مفصلية ولا توجد أضلاع وعددها خمس فقرات ، وتتمفصل الفقرة القطنية الخامسة مع السطح العلوي للفقرة العجزية الأولى مكونة بروزا واضحا يسمى البروز القطني العجزي

الغضاريف :- هي عبارة عن أجسام رقيقة مستديرة ولينة تعمل كوسائد أو مساند لإمتصاص الصدمات الميكانيكية أثناء حركة العمود الفقري .

ويتكون كل غضروف من طبقتين مختلفتين وطبقة خارجية قوية وتلعب دورا هاما في تماسك الفقرات ببعضها البعض

الأعصاب الشوكية :

عدد الأعصاب الشوكية 31 عصب تخرج من النخاع الشوكي من كل جانب خلال ثقب بين الفقرات ويتكون العصب الشوكي من إتحاد الجذر الأمامي للعصب وهو (الجذر المحرك) مع الجذر الخلفي للعصب (وهو الجذر الحسي) وتنقسم الأعصاب الشوكية إلي مجموعات تسمى كل مجموعة بإسم المنطقة التي تتبعها

زيارة الصفحة الأصلية من الموضوع